

Mécanisme de Stress : De l'Homéostasie à l'Épuisement

Comprendre le Syndrome Général d'Adaptation
et ses implications en réflexothérapie.

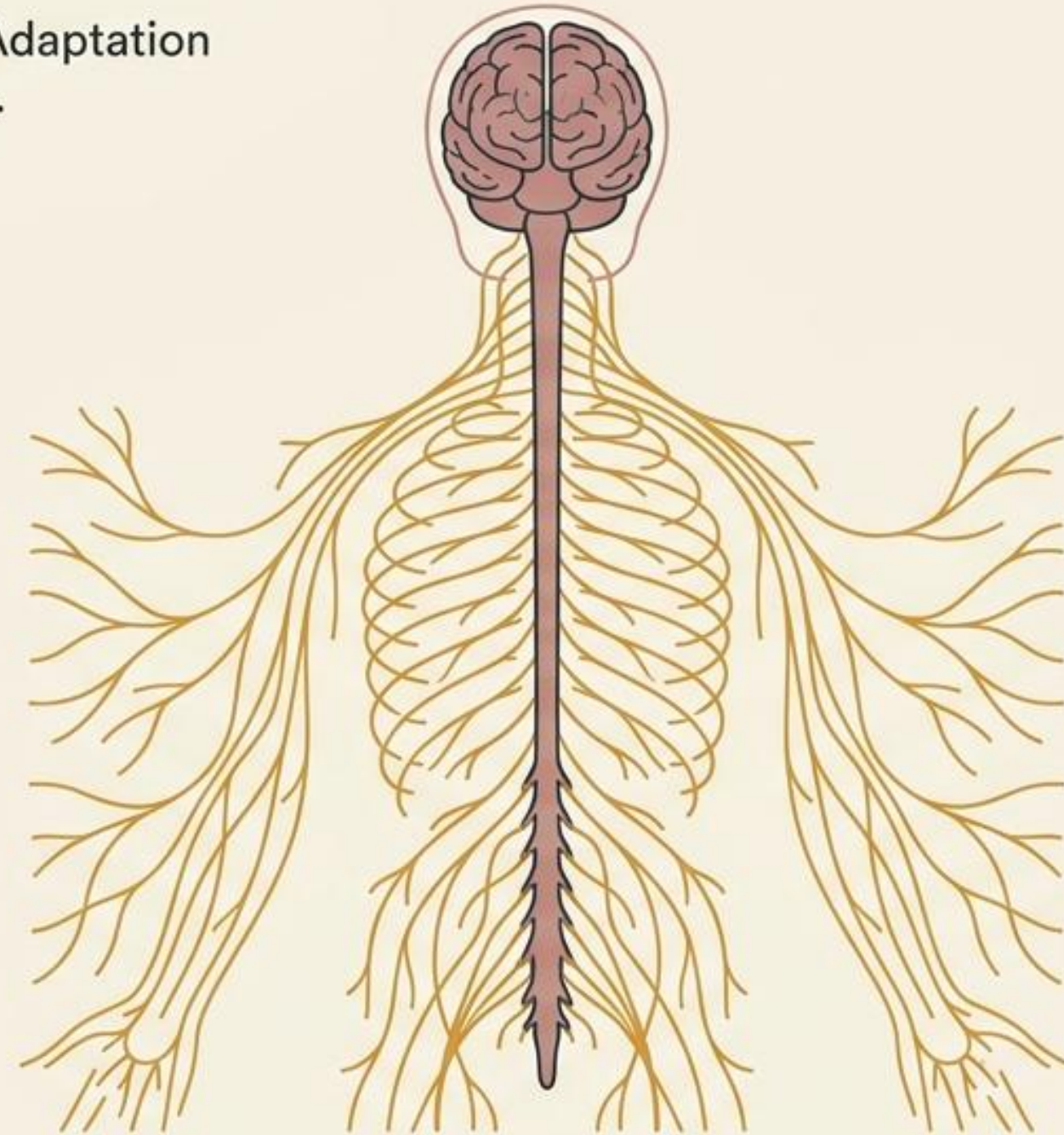


Fig. 5.0 — L'axe neuro-endocrinien du stress.

L'équilibre vital : Homéostasie et Allostasie



Homéostasie

Maintien de la stabilité.
Régulation du milieu intérieur
(température, pH, glycémie).



Allostasie

Capacité d'adaptation.
Maintien de l'homéostasie
dans un contexte changeant.



Stress

Réaction de préservation.
Ensemble des réactions face
à une menace pour limiter
l'écart homéostatique.

Rôle clé du SNA :
Le Système Nerveux
Autonome est en première
ligne pour préserver
l'équilibre interne.

Fig. 5.1 — Définitions fondamentales de la régulation physiologique.

Les trois grands stressseurs et l'effet cumulatif

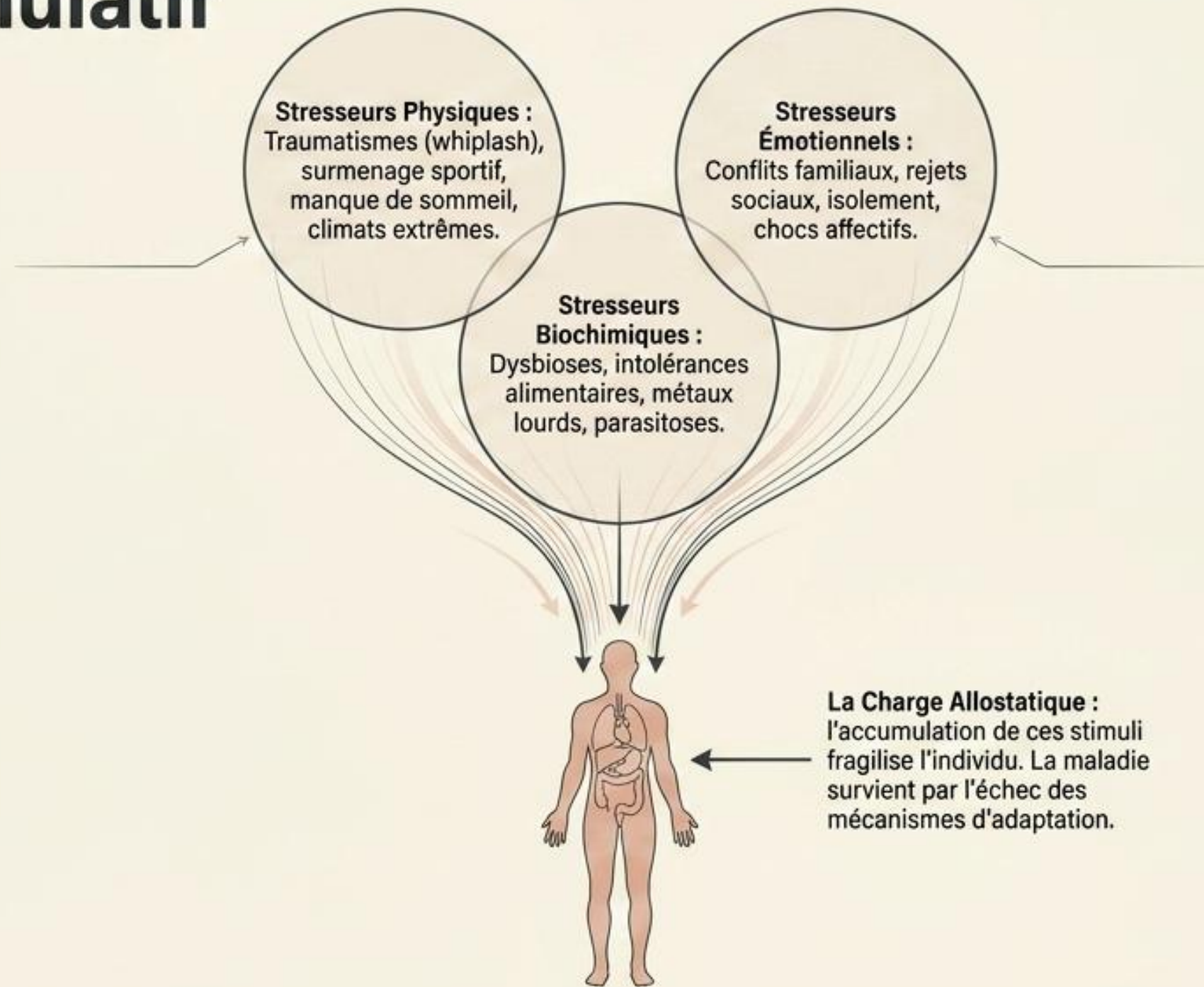


Fig. 5.2 — L'interaction des stressseurs physiques, émotionnels et biochimiques.

Dualité du stress : Distress vs. Eustress

Distress (Négatif)



- **Émotions** : Peur, colère, insécurité, échec.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Dominance du Cortisol.
- **Impact** : Fragilisation des systèmes nerveux, hormonal et immunitaire. Évolution pathogène.

Eustress (Positif)



- **Émotions** : Joie, amour, enthousiasme, sécurité.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Activation neuromédatrice (Adrénaline).
- **Impact** : Réponse adaptative favorable, stimulante et nécessaire à court terme.

Fig. 5.3 — Différenciation de la polarité du stress et de sa réponse hormonale.

Le point de bascule : Cerveau limbique et Hypothalamus

L'interprétation de la menace déclenche la cascade biologique.

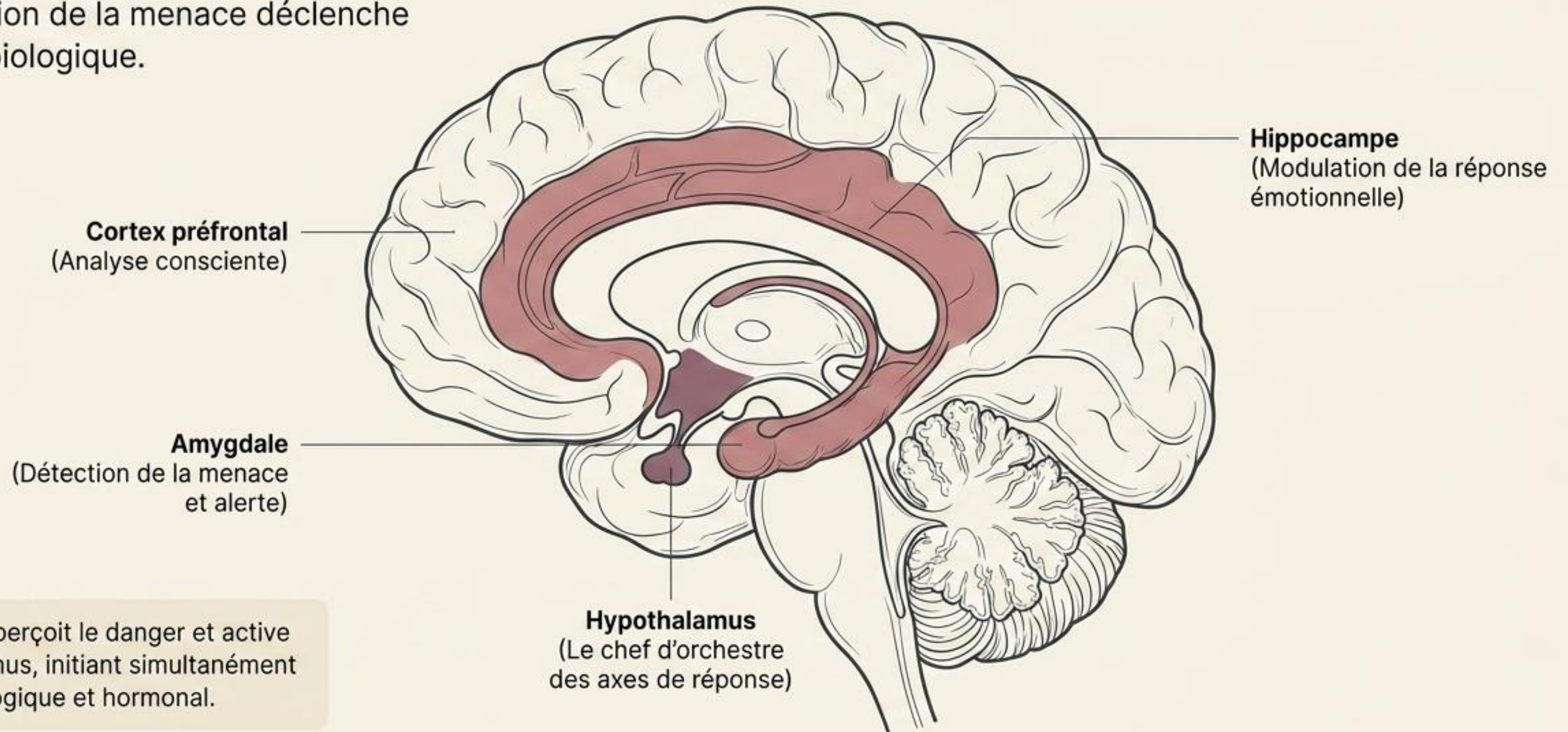


Fig. 5.4 — Anatomie centrale de la détection des stressseurs.

Axes neurologique (SAM) et hormonal (HHS)

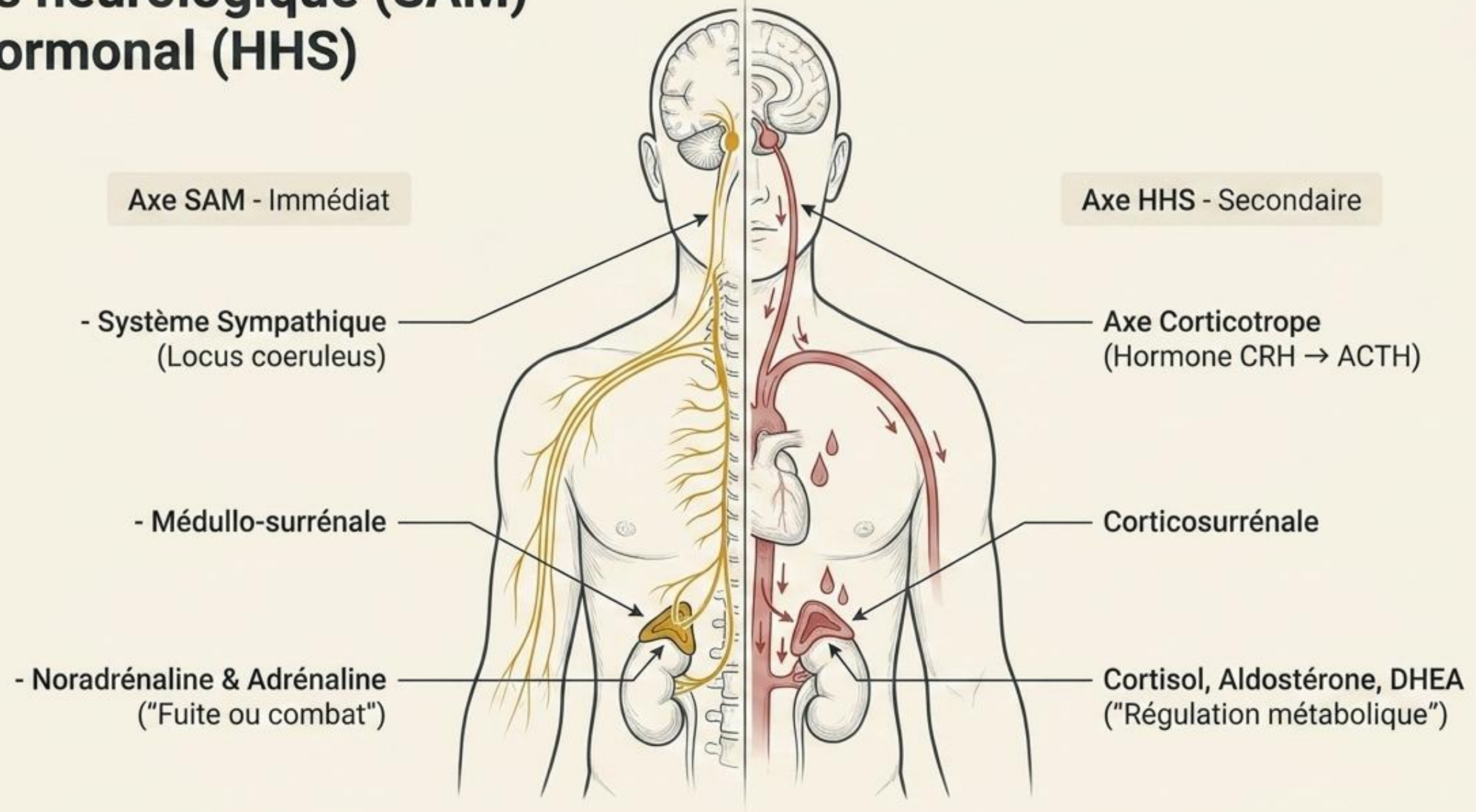


Fig. 5.5 — La réponse sympathique d'urgence précède le soutien neuro-endocrinien.

Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

Modèle d'évolution de l'impact du stress selon Hans Selye.

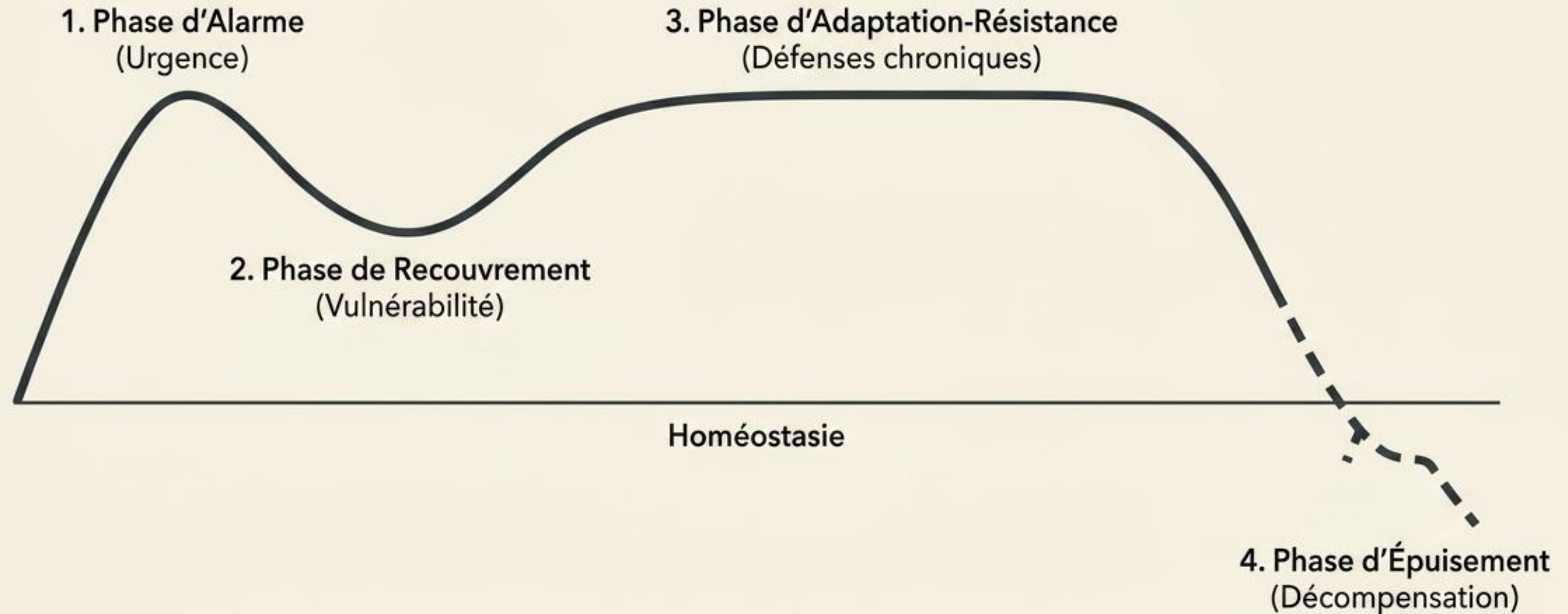
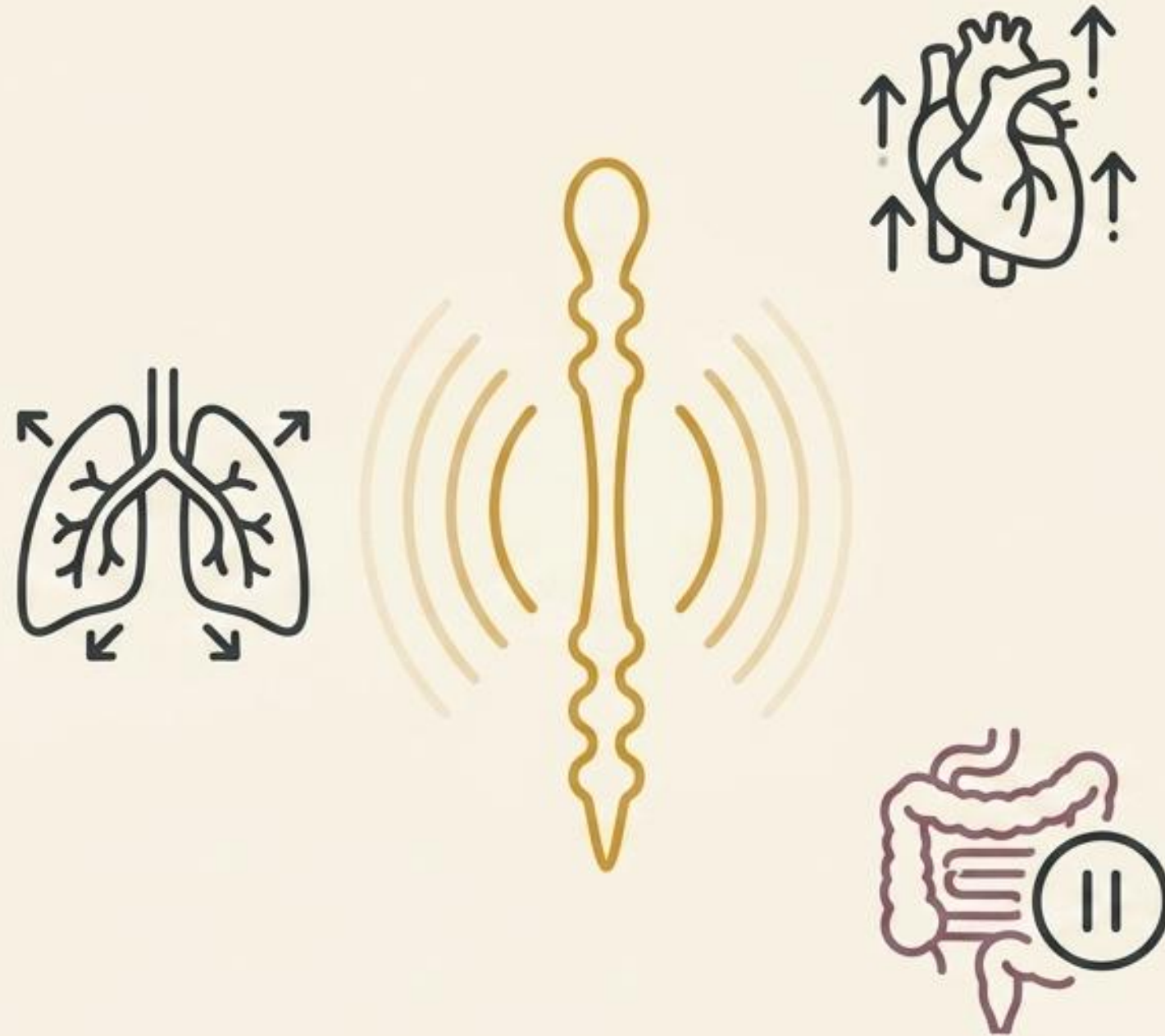


Fig. 5.6 — L'évolution séquentielle de la réponse biologique face à une charge allostatique prolongée.

Phase 1 : L'Alarme et l'Urgence

Mots-clés : Réaction immédiate, mobilisation énergétique, activation exclusive du Sympathique.

Physiologie : Accélération cardiaque et respiratoire. Afflux sanguin musculaire. Suspension temporaire de la digestion et des fonctions gonadiques.



Statut Pathologique : Troubles purement fonctionnels (réversibles). L'intégrité anatomique est préservée.

Fig. 5.7 – Réponse immédiate de survie (déséquilibre passager en faveur du sympathique).

Phase 2 : Recouvrement et Vulnérabilité

Mots-clés : Fatigue, récupération, vulnérabilité passagère (max 72h).

Physiologie : Baisse du cortisol et de l'adrénaline.
Recrudescence des douleurs, évacuation émonctorielle accrue.

Lien Thérapeutique (Loi de Hering) :

En réflexothérapie, cette phase explique les réactions post-séance. La guérison s'opère :

1. Du haut vers le bas
2. Du dedans vers le dehors
3. Du chronique vers l'aigu

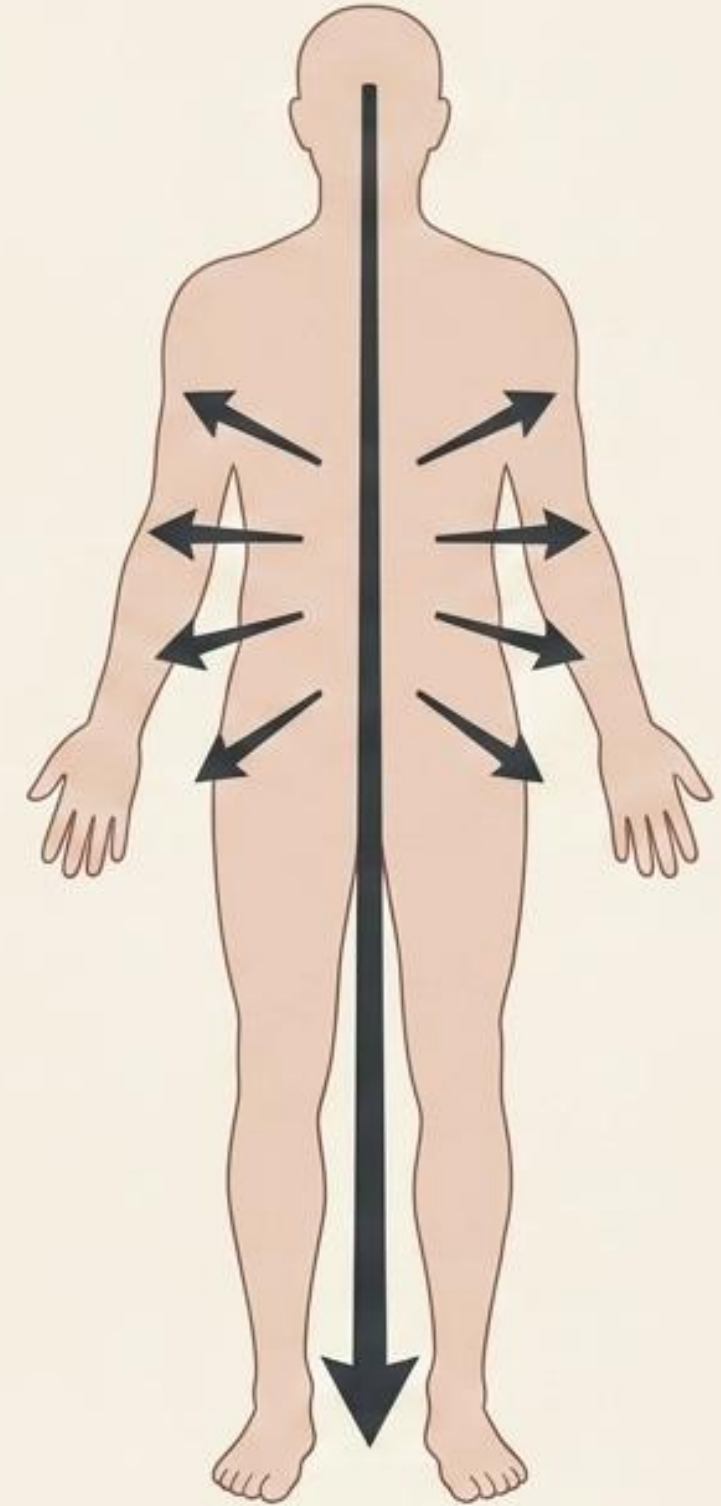
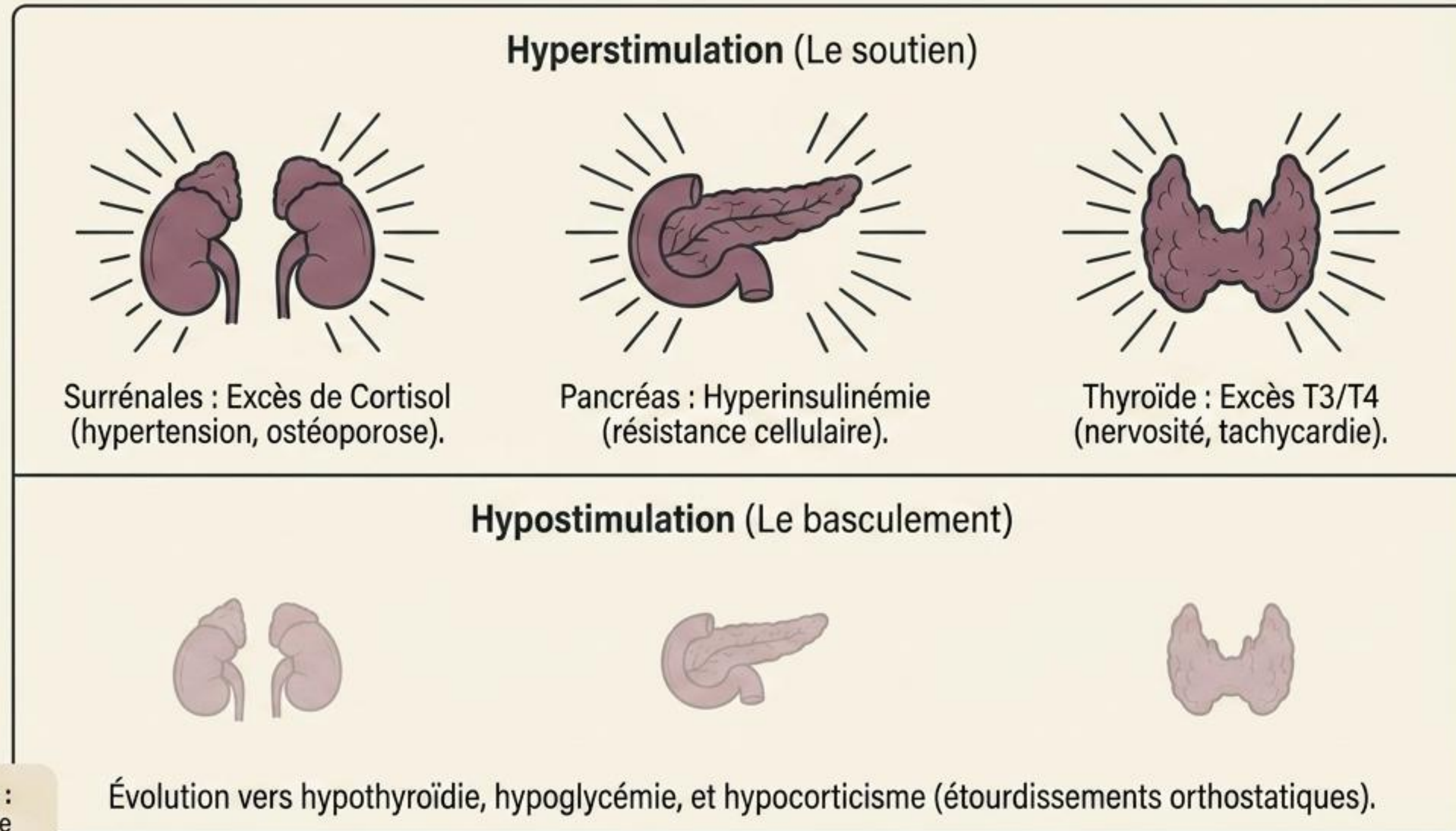


Fig. 5.8 — Période de récupération physiologique et direction des symptômes salutaires.

Phase 3 : Adaptation-Résistance

Mots-clés : Organisation des défenses, chronicité, stressseurs persistants.



Statut Pathologique :
Apparition d'allodynie (douleur exacerbée).
L'intégrité anatomique commence à céder.

Fig. 5.9 — Le coût métabolique de l'adaptation prolongée.

Phase 4 : Épuisement et Décompensation

Mots-clés : Capitulation, renoncement, fin des mécanismes d'adaptation.

Impacts Sévères (Pathologies Chroniques) :

- Axe Neurologique : Alzheimer, Parkinson, atrophie de l'hippocampe.
- Système Immunitaire : Maladies auto-immunes, cancers, inflammations sévères.
- Cardio-vasculaire : Infarctus, AVC.

Lien Thérapeutique (ROP) : À ce stade d'irréversibilité, les thérapies fonctionnelles n'ont plus de visée curative propre ; elles constituent un support palliatif et psychologique.

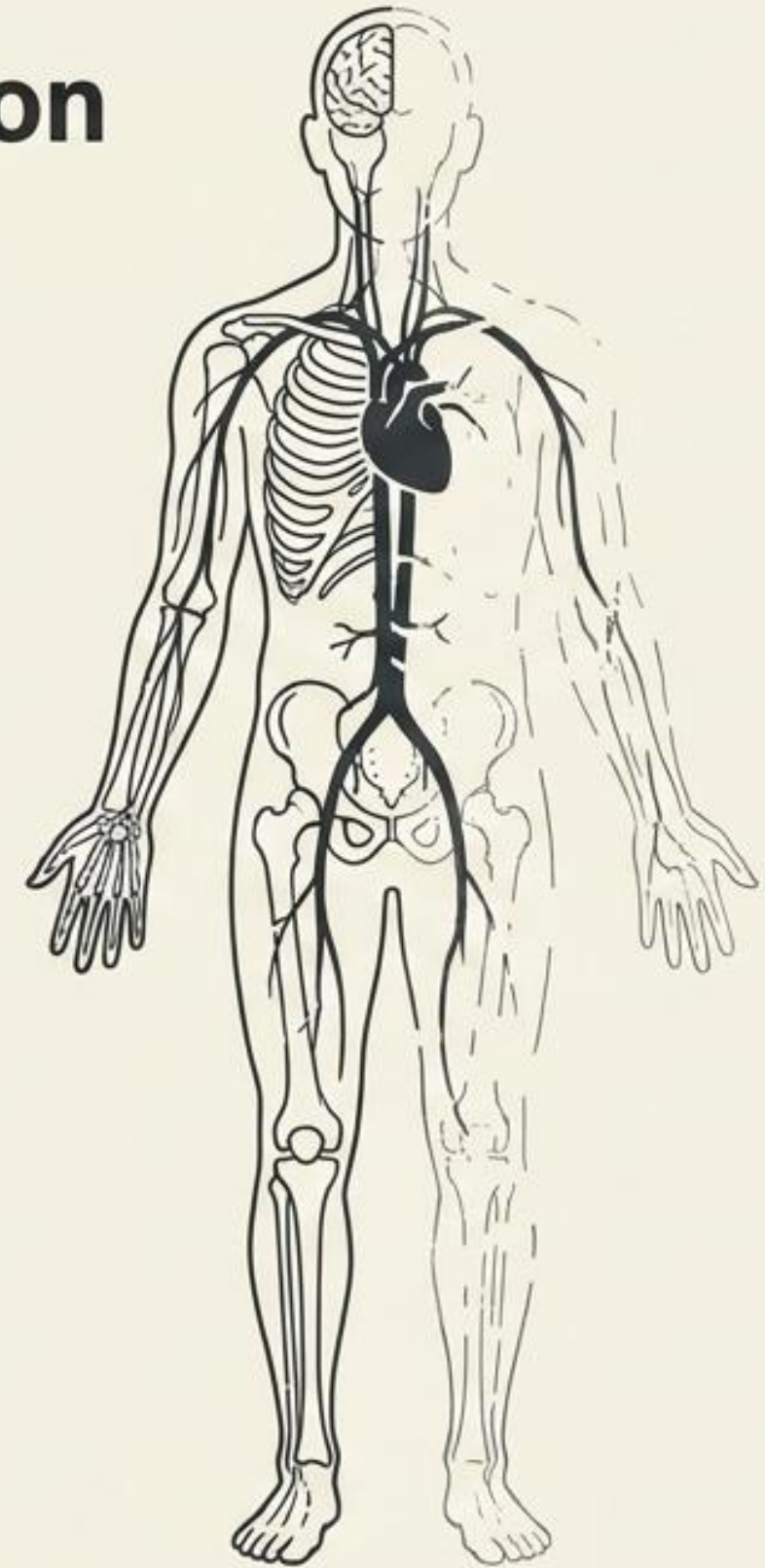


Fig. 5.10 — L'échec final de l'allostasie et l'installation de la lésion irréversible.

Les enveloppes méningées de la moelle spinale

Architecture protectrice et voies de communication neurologique.

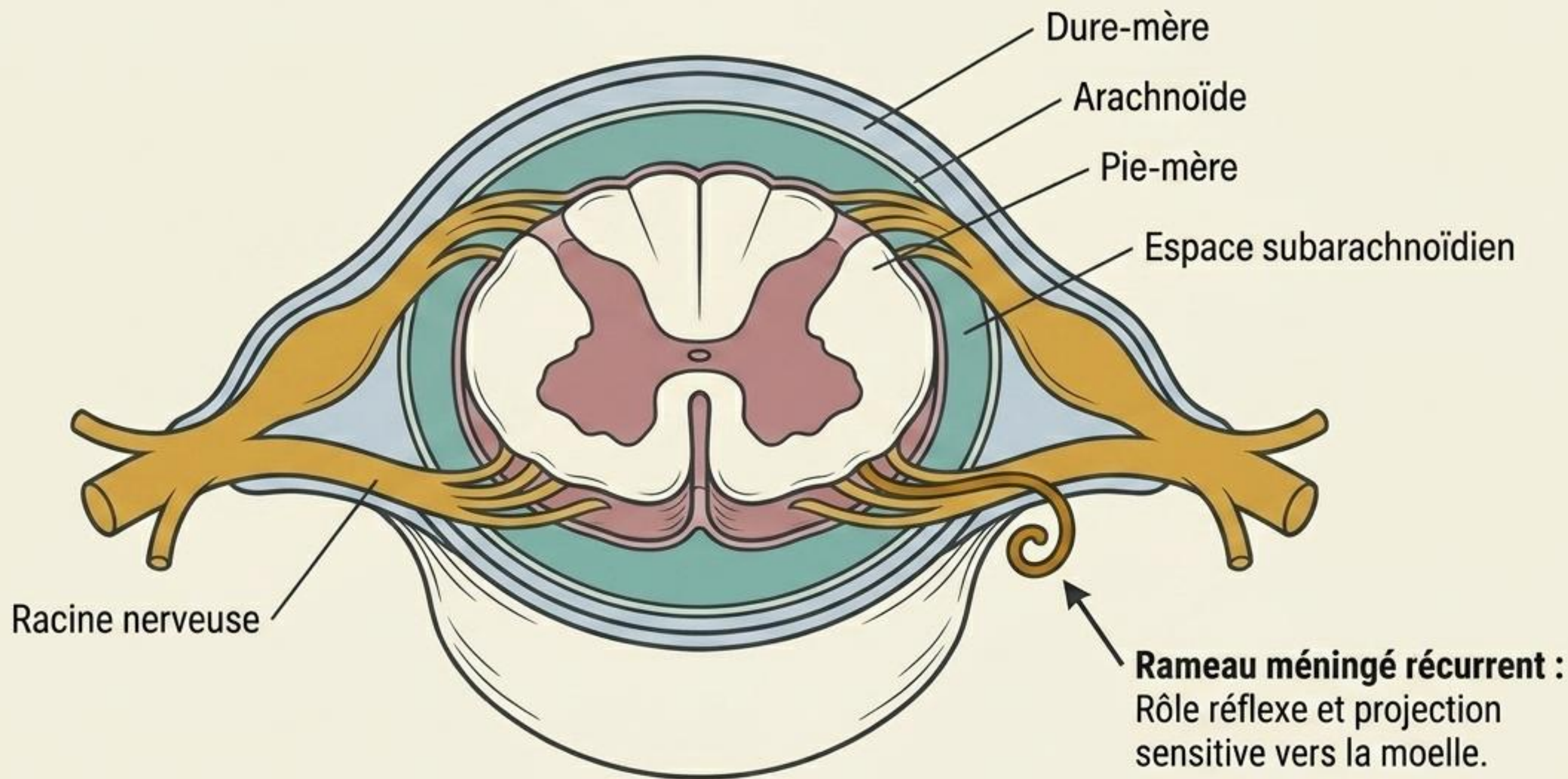
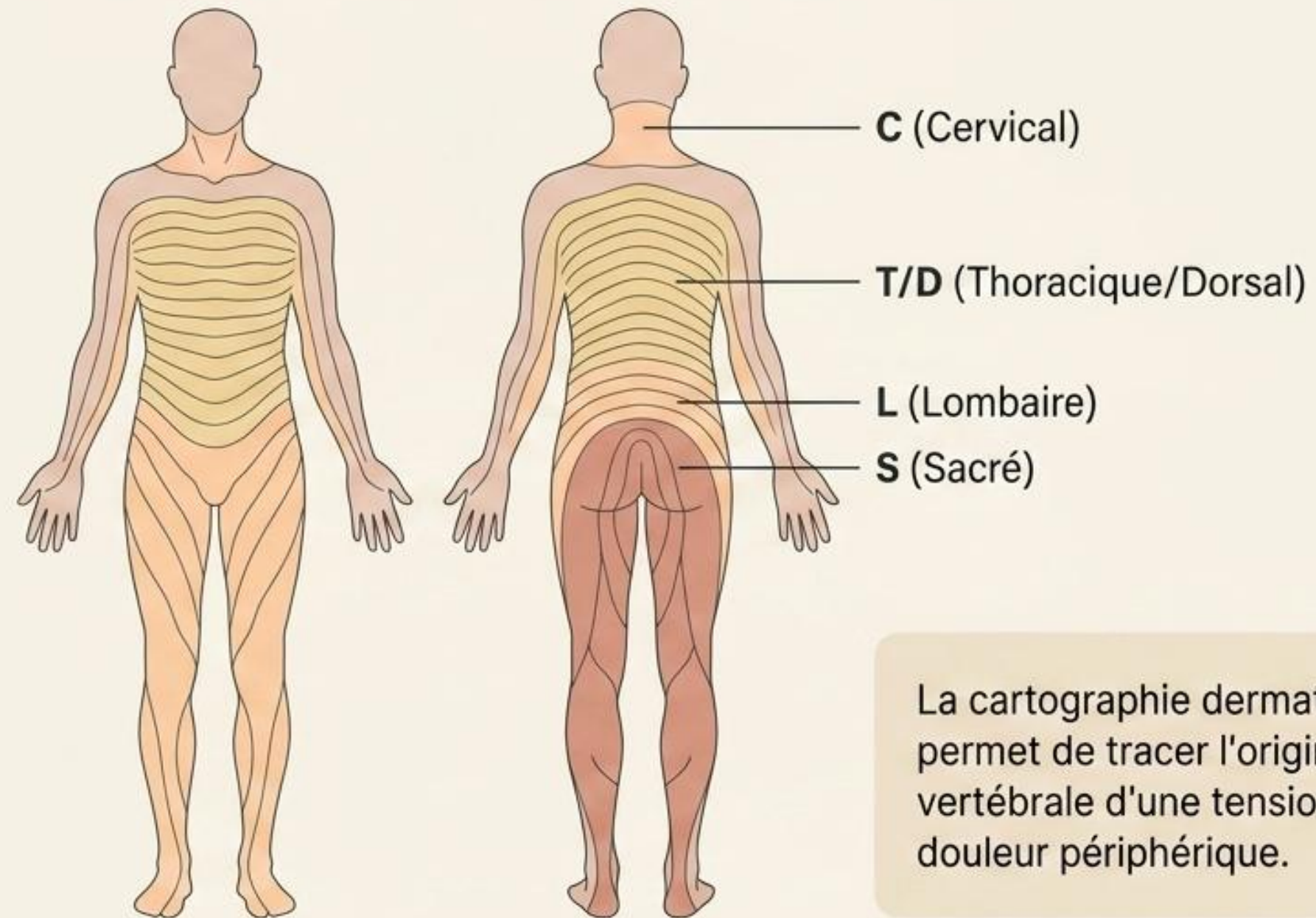


Fig. 5.11 — Anatomie descriptive des méninges spinales.

Les dermatomes : une lecture segmentaire du corps

Chaque territoire cutané correspond à une racine nerveuse spinale spécifique.



La cartographie dermatomérique permet de tracer l'origine vertébrale d'une tension ou d'une douleur périphérique.

Fig. 5.12 — Représentation simplifiée des dermatomes et de leur organisation segmentaire

Organisation myélomérique et projection réflexe

Lien ROP : Comprendre comment l'irritation viscérale due au stress se projette neurologiquement sur les territoires cutanés et musculaires correspondants.

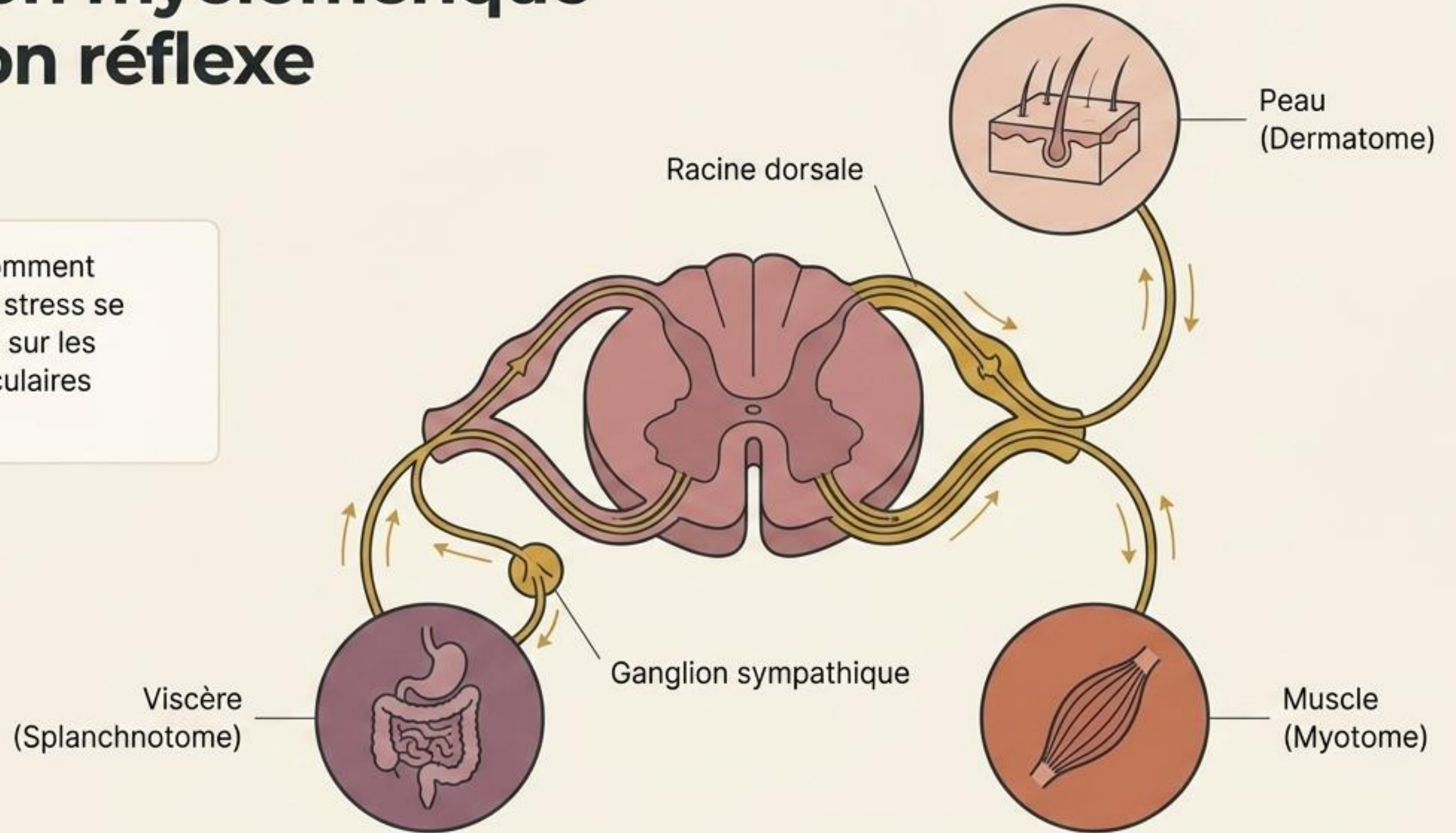
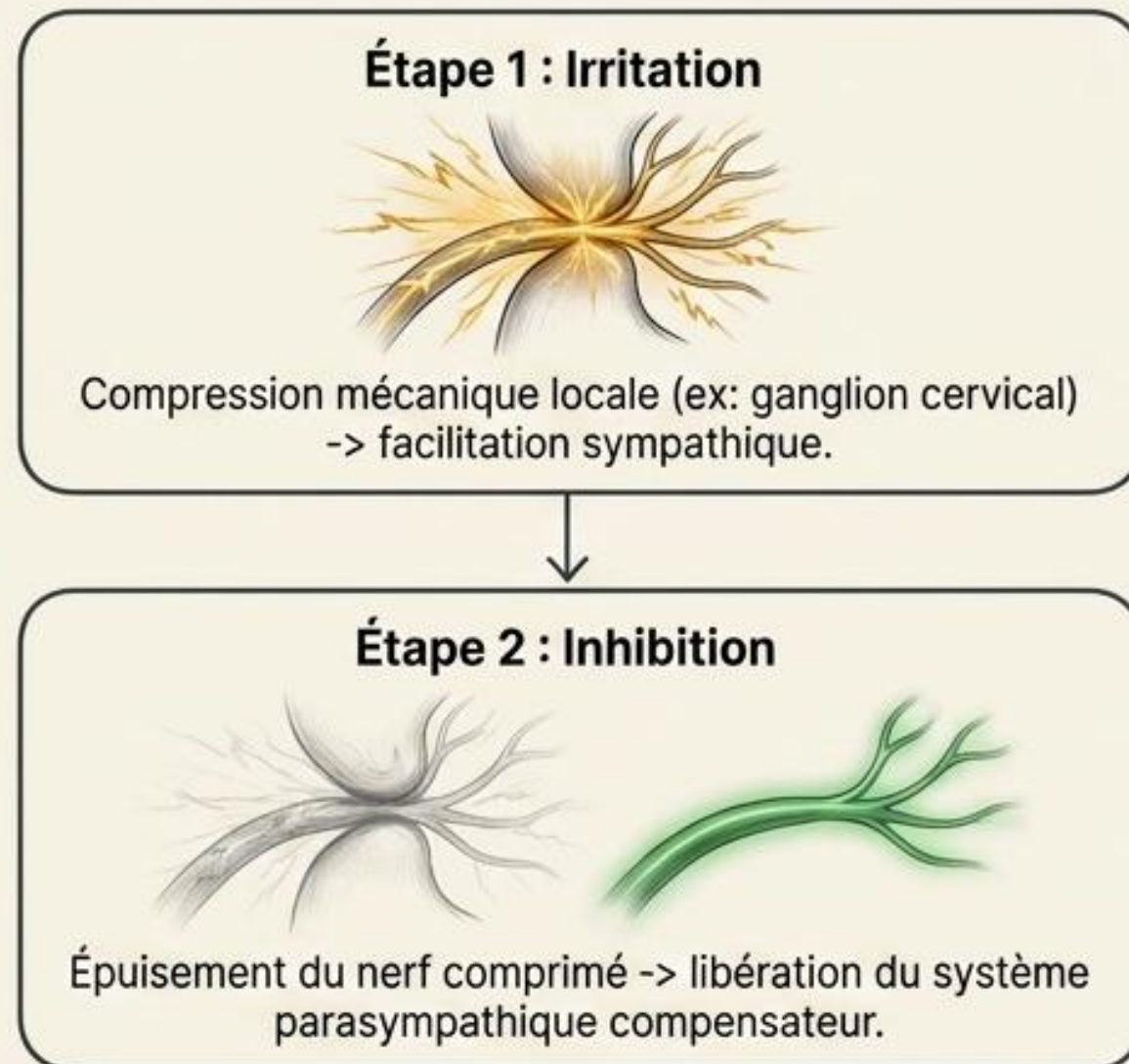


Fig. 5.13 — Le myélomère : carrefour de la souffrance viscérale et du traitement somatique.

Cartographie clinique et Syndrome Locorégional

Le Syndrome Locorégional



Zones Cibles ROP

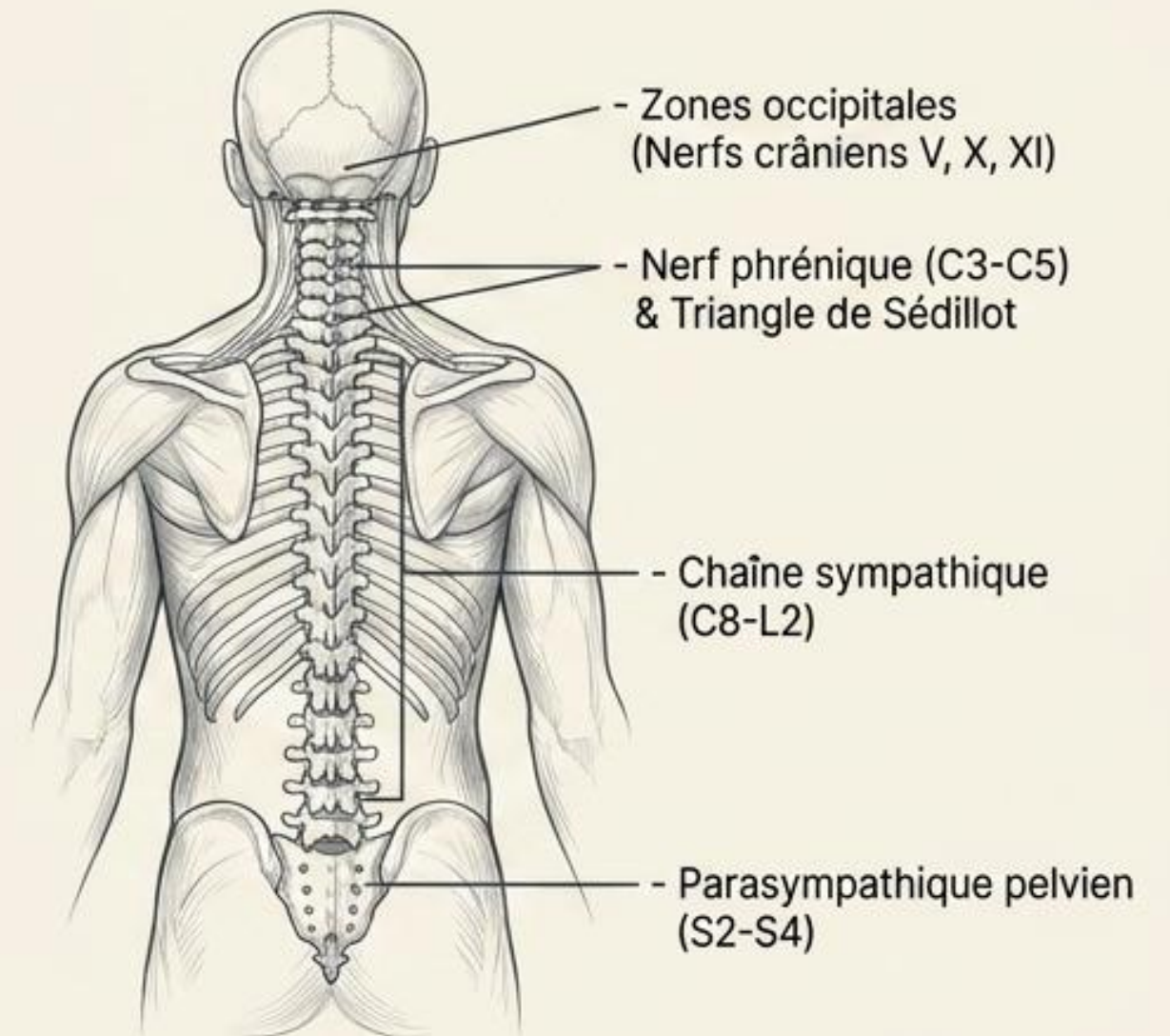


Fig. 5.14 — Synthèse intégrative : les carrefours neuro-végétatifs à traiter face au stress chronique.